

OCPD a OCD — *dwa różne światy*

Podobne nazwy mylą, ale to odrębne zaburzenia. Różnica zaczyna się od jednego pytania: czy to, co robisz, wydaje Ci się słuszne, czy męczące i obce.

CZAS: 12 min Karta orientacyjna **ŹRÓDŁO:** DSM-5-TR (APA, 2022); ICD-11 (WHO, 2022)

JAK UŻYWAĆ

Ta karta wyjaśnia, czym **osobowość anankastyczna (OCPD)** różni się od **zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego (OCD)**. Mimo podobnej nazwy to dwie różne diagnozy, o innym przebiegu i innym leczeniu. Poznasz kluczowe rozróżnienie i porównasz oba w tabeli.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Najważniejsza różnica to stosunek do własnych zachowań. W OCPD wzorzec jest *zgodny z „ja”* (ang. *ego-syntonic*) — perfekcjonizm i kontrola wydają się słuszne, a problem widzą głównie inni. W OCD natręctwa są *obce „ja”* (ang. *ego-dystonic*) — niechciane, męczące, a osoba walczy, by się ich pozbyć. To rozróżnienie decyduje o kierunku terapii, dlatego warto je rozumieć.

01

Kluczowa różnica: słuszne czy obce

OCPD — ZGODNE Z „JA”

„Mam wysokie standardy i to **dobrze**.” Wzorzec wydaje się słuszny; cierpienie odczuwają zwykle bliscy. Niewielka motywacja do zmiany.

OCD — OBCE „JA”

„Te myśli są **męczące** i chcę, żeby zniknęły.” Natręctwa są niechciane; osoba aktywnie z nimi walczy i cierpi z ich powodu.

02



Porównanie

CECHA	OCPD (ANANKASTYCZNE)	OCD (OBSESYJNO-KOMPULSYJNE)
Charakter	trwały wzorzec osobowości	zaburzenie lękowe, epizodyczne
Natręctwa	brak prawdziwych obsesji	natrętne myśli (obsesje)
Rytuały	brak kompulsji rytualnych	czynności przymusowe (kompulsje)
Wgląd	wzorzec wydaje się słuszny	osoba wie, że to nadmiarowe
Cierpi	najczęściej bliscy	sama osoba

03 → Mogą też współwystępować

Choć to różne zaburzenia, część osób ma jednocześnie OCPD i OCD. Bywają wtedy mylone — kluczem do rozróżnienia pozostaje pytanie: czy dane zachowanie jest **celowe i akceptowane** (OCPD), czy **wymuszone i niechciane** (OCD).

Przykład: **porządkowanie**. W OCPD to świadoma dbałość o ład („tak jest dobrze”). W OCD to przymus redukujący lęk („muszę, bo inaczej stanie się coś złego”). To samo zachowanie — inny mechanizm i inne odczucie.

04 ✎ Które bliższe mojemu doświadczeniu

Bez stawiania sobie diagnozy — z ciekawością: czy Twoje wzorce wydają Ci się raczej słuszne, czy raczej męczące i niechciane?

MOJE ZACHOWANIA — SŁUSZNE CZY MĘCZĄCE

— jak je odczuwam

O CO CHCĘ ZAPYTAĆ SPECJALISTĘ

— wątpliwości

Klucz: rozróżnienie OCPD i OCD nie jest akademickim drobiazgiem — wyznacza inny kierunek terapii. OCD leczy się przede wszystkim ekspozycją z powstrzymaniem reakcji wobec konkretnych natręctw; w OCPD pracuje się nad sztywnym, wszechobecnym stylem funkcjonowania i przekonaniami pod nim. Postawienie trafnej diagnozy należy zawsze do specjalisty — ta karta ma tylko pomóc zadać właściwe pytania.